OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 正面

研究定位

2026横断面研究，103人：正常49、MCI 29、AD痴呆25。不能预测个体未来发病。

2026 刊p673

检查条件

SS-OCTA黄斑中心6×6-mm扫描；PLEX Elite 9000。认知诊断参照ADRC/NIA-AA，非单凭影像。

2026 刊p674

GCC观察

AD痴呆63.31 μm，正常67.93 μm；差−4.62 μm（95%CI −8.92至−0.31），P=.03。非诊断切点。

2026 刊p673、675

CCFD观察

MCI 8.12%、AD痴呆9.07%、正常8.33%，呈双相分布。以上均为调整组均值。

2026 刊p673、675、678

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 正面

研究定位

2026横断面研究，103人：正常49、MCI 29、AD痴呆25。不能预测个体未来发病。

2026 刊p673

检查条件

SS-OCTA黄斑中心6×6-mm扫描；PLEX Elite 9000。认知诊断参照ADRC/NIA-AA，非单凭影像。

2026 刊p674

GCC观察

AD痴呆63.31 μm，正常67.93 μm；差−4.62 μm（95%CI −8.92至−0.31），P=.03。非诊断切点。

2026 刊p673、675

CCFD观察

MCI 8.12%、AD痴呆9.07%、正常8.33%，呈双相分布。以上均为调整组均值。

2026 刊p673、675、678

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 正面

研究定位

2026横断面研究，103人：正常49、MCI 29、AD痴呆25。不能预测个体未来发病。

2026 刊p673

检查条件

SS-OCTA黄斑中心6×6-mm扫描；PLEX Elite 9000。认知诊断参照ADRC/NIA-AA，非单凭影像。

2026 刊p674

GCC观察

AD痴呆63.31 μm，正常67.93 μm；差−4.62 μm（95%CI −8.92至−0.31），P=.03。非诊断切点。

2026 刊p673、675

CCFD观察

MCI 8.12%、AD痴呆9.07%、正常8.33%，呈双相分布。以上均为调整组均值。

2026 刊p673、675、678

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 正面

研究定位

2026横断面研究，103人：正常49、MCI 29、AD痴呆25。不能预测个体未来发病。

2026 刊p673

检查条件

SS-OCTA黄斑中心6×6-mm扫描；PLEX Elite 9000。认知诊断参照ADRC/NIA-AA，非单凭影像。

2026 刊p674

GCC观察

AD痴呆63.31 μm，正常67.93 μm；差−4.62 μm（95%CI −8.92至−0.31），P=.03。非诊断切点。

2026 刊p673、675

CCFD观察

MCI 8.12%、AD痴呆9.07%、正常8.33%，呈双相分布。以上均为调整组均值。

2026 刊p673、675、678

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 背面

统计提醒

VSD组间FDR校正后不显著；多变量模型关联不能混作组间差异或因果证据。

2026 刊p675、677–678

模型性能

测试集21人：10/6/5；AUC 0.72~0.87。事后5折验证更保守，小样本性能可能高估。

2026 刊p673、675–676、679

临床边界

原文未建立个体诊断、转诊数值切点、筛查年龄、复查频率或治疗方案。不可凭组均值判定AD。

2026 刊p673、679

下一步与局限

用于研究解读及神经评估衔接；MCI病因混合、性别差异及残余混杂，待外部/纵向验证。

2026 刊p674、679

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 背面

统计提醒

VSD组间FDR校正后不显著；多变量模型关联不能混作组间差异或因果证据。

2026 刊p675、677–678

模型性能

测试集21人：10/6/5；AUC 0.72~0.87。事后5折验证更保守，小样本性能可能高估。

2026 刊p673、675–676、679

临床边界

原文未建立个体诊断、转诊数值切点、筛查年龄、复查频率或治疗方案。不可凭组均值判定AD。

2026 刊p673、679

下一步与局限

用于研究解读及神经评估衔接；MCI病因混合、性别差异及残余混杂，待外部/纵向验证。

2026 刊p674、679

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 背面

统计提醒

VSD组间FDR校正后不显著；多变量模型关联不能混作组间差异或因果证据。

2026 刊p675、677–678

模型性能

测试集21人：10/6/5；AUC 0.72~0.87。事后5折验证更保守，小样本性能可能高估。

2026 刊p673、675–676、679

临床边界

原文未建立个体诊断、转诊数值切点、筛查年龄、复查频率或治疗方案。不可凭组均值判定AD。

2026 刊p673、679

下一步与局限

用于研究解读及神经评估衔接；MCI病因混合、性别差异及残余混杂，待外部/纵向验证。

2026 刊p674、679

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

OCTA与阿尔茨海默病：研究解读

2026 单篇研究 · 背面

统计提醒

VSD组间FDR校正后不显著；多变量模型关联不能混作组间差异或因果证据。

2026 刊p675、677–678

模型性能

测试集21人：10/6/5；AUC 0.72~0.87。事后5折验证更保守，小样本性能可能高估。

2026 刊p673、675–676、679

临床边界

原文未建立个体诊断、转诊数值切点、筛查年龄、复查频率或治疗方案。不可凭组均值判定AD。

2026 刊p673、679

下一步与局限

用于研究解读及神经评估衔接；MCI病因混合、性别差异及残余混杂，待外部/纵向验证。

2026 刊p674、679

单篇研究方案，不等同指南推荐。详见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转